ARCTIC a 10 años: ¿cómo están los pacientes con artritis reumatoide temprana tratados por objetivos una década después?

Nordberg LB, et al. Ten-year outcomes after treat-to-target therapy in early rheumatoid arthritis (ARCTIC-FORWARD). *Ann Rheum Dis*. 2026. doi:10.1016/j.ard.2026.09.003 (acceso abierto)

Versión 1.0 · Revisado el 24 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Refuerza tratar por objetivos
Apoya la estrategia temprana e intensiva de EULAR; no introduce nada nuevo.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Descriptivo, con buen seguimiento
82 % de los vivos acudió; sin grupo comparador con artritis reumatoide.

CUIDADO AL INTERPRETAR
Asociación, no causa
La remisión temprana predice, pero puede reflejar una enfermedad más benigna.

En 30 segundos. El ensayo ARCTIC (2010–2013) trató 230 pacientes con artritis reumatoide temprana con metotrexato, puente corto de prednisolona y ajustes estrictos hacia la remisión. Diez años después, 82 % de los evaluados estaba en remisión por DAS, el daño radiográfico fue mínimo, la función se acercó a la de la población general y la supervivencia fue comparable. Quienes lograron remisión sostenida en los primeros 2 años estaban mejor a los 10. Es una gran noticia para el paciente, pero es una cohorte, no un ensayo.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
El seguimiento observacional de un ensayo: qué se pierde al salir de la aleatorización, por qué "los que lograron remisión temprana están mejor" no prueba que la remisión temprana sea la causa, y cómo leer una comparación con la población general.

1 De dónde vienen los pacientes

ENSAYO ORIGINAL	ARCTIC: 230 adultos de 18 a 75 años con artritis reumatoide (criterios ACR/EULAR 2010), <2 años de síntomas y sin FARME previo. Comparó tratar por objetivos con o sin ultrasonido; a los 2 años los resultados fueron similares y aquí **se unieron ambos brazos**.
TRATAMIENTO INICIAL	Metotrexato a dosis adecuada y prednisolona puente (de 15 mg a 0 en 7 semanas), con ajustes predefinidos y control estrecho durante 2 años.
ENTRE LOS 2 Y 10 AÑOS	Atención habitual en el sistema público noruego, con guías alineadas a EULAR; sin recolección sistemática. Una parte participó en un ensayo de retiro de FARME (ARCTIC REWIND).
VISITA A 10 AÑOS	218 vivos; **179 acudieron (82 %)**. De los que no acudieron se revisó el expediente. Seguimiento financiado con fondos públicos noruegos.

2 Cómo estaban a los 10 años

MEDIDA	RESULTADO
Remisión por DAS (<1.6)	**146/177 (82 %)**
Remisión Booleana ACR/EULAR 2.0	100 (57 %)
Sin articulaciones inflamadas · sin Doppler de poder	134 (76 %) · 139 (80 %)
Cambio en Sharp-van der Heijde desde el inicio, mediana (RIC)	2.0 (0.5–4.5), ~0.2 por año

Progresión radiográfica (≥1 unidad por año)	13 (8 %)
Muertes en 10 años	12 (5 %); supervivencia similar a la población general
Tratamiento actual	Monoterapia con FARMEsc 44 % (metotrexato ~17 mg/semana) · biológico o sintético dirigido 35 % · sin FARME 15 % · prednisolona 9 %

3 Remisión sostenida temprana y desenlace a 10 años

A LOS 10 AÑOS	REMISIÓN SOSTENIDA A 2 AÑOS (N=101)	SIN REMISIÓN SOSTENIDA (N=78)	P
Remisión Booleana 2.0	**72 %**	37 %	<0.001
Función física (PROMIS, media)	**53.4**	44.2	<0.001
Sharp-van der Heijde total, mediana	3.0	3.0	0.19
Monoterapia con FARMEsc	55 %	30 %	0.001
Biológico + FARMEsc	13 %	26 %	0.03

DATO DEL ARTÍCULO Remisión sostenida = DAS <1.6 a los 16, 20 y 24 meses. PROMIS: media poblacional 50, mayor es mejor.

4 Cómo leer estos resultados

- **Ya no hay aleatorización:** el ensayo comparó dos estrategias; a 10 años se unieron los brazos y se describe una cohorte. No hay un grupo con artritis reumatoide tratado de otra forma para comparar.
- **"Los que lograron remisión temprana están mejor" es una asociación.** **INTERPRETACIÓN** Puede ser efecto del control temprano de la inflamación o puede ser que esos pacientes tuvieran una enfermedad más benigna o más respondedora desde el inicio. Que los que no lograron remisión usaran más biológicos apunta a esa diferencia de base. Los autores lo reconocen.
- **La comparación con la población general es una referencia externa:** iguala edad y sexo, pero no otras diferencias. Además, otras cohortes mostraron exceso de mortalidad recién después de 13 a 20 años.
- **Sesgo de anticipación (lead time):** los criterios de 2010 clasifican antes, a veces a pacientes con enfermedad leve o autolimitada que no cumplirían los de 1987. Empezar a contar antes hace que el pronóstico parezca mejor aunque la enfermedad sea la misma.
- **Sin diferencia radiográfica entre grupos** porque casi nadie progresó: con tan poca variación, es difícil distinguir.

CONCEPTO CLAVE · LA ESCALERA DE DISEÑOS

INTERPRETACIÓN Un ensayo aleatorizado responde "¿la estrategia A es mejor que la B?". Su seguimiento a largo plazo, sin aleatorización, responde otra pregunta: "¿qué les pasó a los pacientes tratados así?". La primera permite hablar de causa; la segunda, de pronóstico y de asociaciones. Ambas son útiles, pero no intercambiables. La fortaleza de ARCTIC a 10 años es el **seguimiento alto (82 %)**, muy por arriba del 50–70 % habitual a 10 años en cohortes de artritis reumatoide; su límite es que **no tiene comparador**.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Seguimiento	82 % de los vivos acudió; de los demás se revisó el expediente. Los que no acudieron eran mayores y la mayoría estaba en remisión en su última consulta.	Confirmado
● Medición	Radiografías leídas por dos lectores cegados a la clínica; ultrasonido estandarizado; función por cuestionarios y fuerza de prensión.	Confirmado
● Comparador	Sin grupo con artritis reumatoide tratado de otra forma; población general como referencia externa.	Reconocido por los autores

Años 2 a 10	Seguimiento menos estrecho, sin recolección sistemática; tratamientos variables entre centros; algunos pacientes redujeron o suspendieron FARME en un ensayo de retiro.	Reconocido por los autores
Remisión temprana	La asociación con mejor desenlace no prueba causalidad: posible enfermedad más benigna de base.	Reconocido por los autores
Lead time	Inclusión temprana con criterios 2010 y síntomas cortos.	Reconocido por los autores
Financiamiento	Público y académico (REMEDY, Consejo de Investigación de Noruega, autoridad regional de salud y una beca privada).	Confirmado
Aplicabilidad	Sistema público con acceso a biológicos y control estrecho; 84 % con anti-CCP positivo. El resultado depende de poder replicar la intensidad del tratamiento inicial.	Interpretación editorial

6 Dónde encaja con lo previo

DATO DEL ARTÍCULO En BeSt, a 10 años, 53 % estaba en remisión por DAS, y en ESPOIR 52 % en remisión por DAS28. Los autores advierten que la comparación es difícil: difieren en tratamiento, objetivo (BeSt buscaba DAS ≤2.4, no remisión), criterios de inclusión y pérdidas. INTERPRETACIÓN Las cifras de ARCTIC son las mejores reportadas en una cohorte de tratamiento por objetivos, pero no se pueden atribuir solo a la estrategia.

Pregunta de repaso: los pacientes con remisión sostenida a 2 años tuvieron mejor función a 10 años. ¿Demuestra que lograr la remisión temprana causa ese beneficio?

Respuesta. No. La remisión sostenida no se asignó al azar: los pacientes que la logran pueden tener una enfermedad menos agresiva o más respondedora desde el inicio, y eso explicaría por sí solo la mejor función a 10 años. El hallazgo es útil como **marcador pronóstico** y es coherente con la recomendación de buscar remisión temprana, pero para demostrar causalidad se necesitaría comparar estrategias asignadas al azar.

¿Qué aprendí de medicina?

- Con tratamiento temprano por objetivos, **82 %** estaba en remisión a 10 años y el daño radiográfico fue mínimo.
- 44 % seguía con un solo FARME convencional (casi siempre metotrexato); 35 % con biológico o sintético dirigido; 9 % con prednisolona.
- La remisión sostenida temprana es un buen **marcador pronóstico**.
- Es un mensaje realista y optimista para el paciente recién diagnosticado.

¿Qué aprendí de investigación?

- El seguimiento de un ensayo sin aleatorización es una **cohorte**.
- Comparar subgrupos que el azar no formó da **asociaciones**.
- La población general es una referencia, no un control.
- Vigila el **sesgo de anticipación** cuando cambian los criterios diagnósticos.

7 Referencias

1. Nordberg LB, Sundlisæter NP, Brinkmann GH, et al. Ten-year outcomes after treat-to-target therapy in early rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis*. 2026. doi:10.1016/j.ard.2026.09.003
2. Haavardsholm EA, Aga AB, Olsen IC, et al. Ultrasound in management of rheumatoid arthritis: ARCTIC randomised controlled strategy trial. *BMJ*. 2016;354:i4205. doi:10.1136/bmj.i4205

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. No sustituye la lectura del artículo original ni el juicio clínico.